

Protocolos de monitoramento de pacientes hospitalizados

Princípios Gerais dos Protocolos

1. Individualização: A frequência é adaptada para cada paciente.
2. Condição Clínica: Pacientes mais instáveis são monitorados com mais frequência.
3. Pós-Procedimentos: A frequência aumenta após cirurgias, procedimentos invasivos ou mudanças de medicação.
4. Instituição: Cada hospital tem seu próprio manual de procedimentos (Protocolos Operacionais Padrão - POPs).
5. Sistematização: Muitas vezes, as verificações são feitas em horários pré-definidos (ex: 6h, 14h, 22h) para padronizar a coleta de dados.

Estratificação por Frequência e Situação Clínica

A tabela a seguir resume as frequências típicas:

Situação Clínica do Paciente	Frequência de Verificação	Justificativa e Observações
1. Paciente Estável (Enfermaria)	A cada 8 horas (turnos de 6h, 14h, 22h) ou 1 vez ao dia, se muito estável.	Monitoramento de rotina para detecção precoce de alterações. A frequência pode ser reduzida se o paciente estiver em alta iminente.
2. Paciente Instável / Pós-Cirúrgico Imediato	A cada 15-30 minutos inicialmente, evoluindo para 1-2 horas e depois para 4 horas conforme a estabilização.	Período de alto risco para complicações como hemorragia, choque, depressão respiratória por anestésicos.
3. Unidade de Terapia Intensiva (UTI)	Contínua ou a cada hora (ou conforme a necessidade).	Pacientes críticos, frequentemente com monitoração invasiva e contínua (pressão arterial invasiva, ECG, saturação de O ₂). As verificações manuais complementam os dados do monitor.
4. Mudança de Condição / Evento Adverso	Imediatamente e seriado (a cada 5-15 minutos até estabilizar).	Resposta a sinais de alerta como dor torácica, queda de pressão, taquicardia, dispneia, alteração do nível de consciência.
5. Administração de Medicamentos de Risco	Antes, durante e após a administração.	Exemplos: Antihipertensivos (verificar PA), Digitálicos (verificar FC), Quimioterápicos, Opioides (verificar FR).
6. Protocolos Específicos (Ex: Sepsis, IAM, AVC)	Conforme o protocolo da doença, podendo ser a cada 1-2 horas ou mais.	Segue diretrizes nacionais e internacionais para o manejo de condições específicas que exigem monitorização rigorosa.

Protocolos de Sensoriamento (Como é Feito)

1. Pressão Arterial (PA)

- **Método Primário:** Esfigmomanômetro aneróide ou digital, com manguito de tamanho adequado (a largura deve ser de 40% da circunferência do braço).
- **Técnica:**
 - Paciente em repouso por pelo menos 5 minutos, com as costas apoiadas e pés no chão.
 - Braço na altura do coração, manguito sobre a artéria braquial.
 - Verificação da PA em ambos os braços na primeira vez.
- **Frequência Cardíaca (FC):** É aferida simultaneamente, palpando o pulso radial ou apical (com estetoscópio) por 30 ou 60 segundos.

2. Frequência Respiratória (FR)

- **Método Primário:** Observação direta e discreta. É considerado o sinal vital mais negligenciado, mas um dos mais importantes para detectar deterioração.
- **Técnica:**
 - Observar a elevação e o abaixamento do tórax por 1 minuto inteiro (não extrapolar de 15 ou 30 segundos), sem que o paciente perceba (para não alterar o padrão respiratório).
 - Notar também a profundidade e o ritmo da respiração.

3. Temperatura

- **Método Primário:** Varia conforme a política do hospital e a condição do paciente.

Temporal / Axilar: Mais comum, não invasivo. Pode ser menos preciso.

- Oral: Requer cooperação do paciente. Contraindicado em pacientes confusos ou com alteração de consciência.
- Timpânico (ouvido): Rápido e conveniente, mas a técnica correta é crucial para precisão.
- Retal: Considerado o "padrão-ouro" de precisão, mas mais invasivo. Usado quando é necessária máxima precisão.

Valores de Alerta (Parâmetros que Acionam uma Resposta)

Os hospitais utilizam sistemas de escore de alerta precoce (como o MEWS - Modified Early Warning Score). Valores fora da faixa normal acionam notificações à equipe de enfermagem e, se necessário, ao médico.

Sinal Vital	Faixa Normal Adulto	Valor de Alerta (Gatilho para Ação)
Pressão Arterial (PA)	120/80 mmHg (em média)	Sistólica < 90 ou > 180 mmHg
Frequência Cardíaca (FC)	60-100 bpm	< 40 ou > 120 bpm
Frequência Respiratória (FR)	12-20 rpm	< 10 ou > 24 rpm
Temperatura	36.1 - 37.2°C (axilar)	< 36.0°C (Hipotermia) ou > 38.0°C (Febre)
Saturação de O ₂ (SpO ₂)	≥ 95%	< 90% (em ar ambiente)

Concluindo, os protocolos de sensoriamento de sinais vitais são a espinha dorsal da monitorização hospitalar. Eles são dinâmicos, baseados em evidências e fundamentais para a segurança do paciente. A chave é a avaliação clínica contínua: os sinais vitais devem ser sempre interpretados em conjunto com o estado geral do paciente, e qualquer alteração significativa deve ser comunicada e documentada imediatamente, seguindo o princípio do SBAR (Situação, Background, Avaliação, Recomendação).

Abaixo estão os principais órgãos e as normas/protocolos que eles estabelecem:

1. Organismos Internacionais e Diretrizes Globais

- Organização Mundial da Saúde (OMS):
 - O que define: A OMS publica diretrizes gerais para a prática clínica essencial e para o manejo de condições específicas que exigem monitorização rigorosa. Por exemplo, suas diretrizes para o manejo de sepse, hipertensão ou infarto agudo do miocárdio incluem protocolos específicos de frequência de verificação de sinais vitais.
 - Exemplo Prático: No "Pacote de Sobrevivência à Sepse", a monitorização hemodinâmica frequente (PA, FC, FR) é uma recomendação central.
- The Joint Commission (TJC) - (Comissão Conjunta):
 - O que define: Embora não defina a frequência exata, a TJC, principal órgão de acreditação dos EUA com influência global, estabelece Padrões de Acreditação Hospitalar. Eles exigem que os hospitais tenham políticas próprias, baseadas em evidências, para a avaliação e monitorização de pacientes, incluindo a frequência de verificação de sinais vitais. A não adesão aos protocolos institucionais pode resultar em perda de acreditação.
- Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN):
 - O que define: Estabelece os padrões éticos e de prática profissional da enfermagem mundial, enfatizando a responsabilidade do enfermeiro na avaliação contínua do paciente, o que inclui a correta aferição e interpretação dos sinais vitais.

2. Normas e Protocolos Nacionais no Brasil

No Brasil, a regulação é bastante estruturada e envolve vários órgãos:

- Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA):
 - O que define: A ANVISA é o órgão regulador federal mais importante para protocolos de segurança do paciente em serviços de saúde.
 - Normas Principais:
 - Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 36/2013: Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e cria o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). Esta resolução obriga os hospitais a implementarem Protocolos de Segurança, entre os quais está indiretamente o de monitorização de sinais vitais, como base para outros protocolos (como o de Identificação do Paciente e o de Prevenção de Quedas);
 - Protocolos Básicos do PNSP: Embora não haja um protocolo somente para sinais vitais, a monitorização adequada é um pilar para a efetividade de protocolos como:
 - Protocolo de Prevenção de Úlceras por Pressão;
 - Protocolo de Manejo da Dor;
 - Protocolo de Prevenção de Quedas;
- Conselho Federal de Enfermagem (COFEN):
 - O que define: Regulamenta a prática da enfermagem no Brasil. A aferição de sinais vitais é uma atividade privativa do Enfermeiro (que delega e supervisiona a equipe de técnicos e auxiliares).
 - Norma Principal:
 - Resolução COFEN nº 589/2018: Aprova a Norma Técnica (NT) 01/2018 sobre a Atuação da Equipe de Enfermagem no Rastreamento e Monitoramento de Sinais de Deterioração do Estado Clínico do Paciente. Esta é uma das normas mais diretamente relacionadas à sua pergunta. Ela estabelece que a equipe de enfermagem deve:
 - Realizar a avaliação clínica e a aferição de sinais vitais na admissão do paciente;
 - Estabelecer a frequência de monitoramento conforme a condição clínica, utilizando sistemas de escore de alerta precoce (como o MEWS);
 - Notificar imediatamente ao enfermeiro e/ou médico quaisquer sinais de deterioração.
- Sociedades de Especialidades Médicas e de Enfermagem:
 - Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn): Promove discussões e publicações sobre as melhores práticas.
 - Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), etc.: Elaboram diretrizes para condições específicas (ex: tratamento de hipertensão, manejo do paciente crítico) que incluem protocolos detalhados de monitorização.
- Ministério da Saúde:
 - O que define: Publica manuais e protocolos para a rede pública (SUS), como os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para diversas doenças, que orientam a frequência de monitoramento.

3. Sistemas de Escore de Alerta Precoce (Ex.: MEWS)

Embora não sejam "órgãos", os sistemas de escore são protocolos operacionais baseados em evidências:

- MEWS (Modified Early Warning Score):
 - O que é: Um sistema de pontuação validado internacionalmente que usa os sinais vitais (PA, FC, FR, temperatura, nível de consciência) para identificar precocemente pacientes com risco de deterioração clínica.
 - Quem define sua adoção: A decisão de usar o MEWS ou um sistema similar (como o NEWS) é feita por cada hospital, mas sua estrutura é baseada em vasta literatura médica. A Resolução COFEN 589/2018 recomenda fortemente o uso desses sistemas.

Resumo Prático: Como Tudo se Aplica em um Hospital

1. Base Legal/Regulatória: A ANVISA (RDC 36/2013) e o COFEN (Res. 589/2018) estabelecem a obrigatoriedade de se ter protocolos.
2. Adaptação Institucional: Cada hospital cria seus Protocolos Operacionais Padrão (POPs) ou manuais de enfermagem, detalhando:
 - A técnica correta para aferir cada sinal vital.
 - A frequência mínima para diferentes perfis de pacientes (estável, pós-operatório, crítico).
 - Os parâmetros de alerta (valores críticos) que acionam o escore de alerta precoce e a comunicação com a equipe médica (usando ferramentas como SBAR).
3. Guia Clínico: As diretrizes da OMS e das sociedades de especialidade embasam tecnicamente os POPs para condições específicas.

Os protocolos de sinais vitais são definidos por uma estrutura em camadas, que vai das diretrizes internacionais e normas federais brasileiras (ANVISA/COFEN) até os protocolos internos de cada hospital, sempre com o objetivo de garantir uma assistência segura e baseada em evidências.